

**WASHINGTON LUIZ FERREIRA RIOS  
WALDEMAR NAVES DO AMARAL**

**MANUAL PRÁTICO  
DE OBSTETRÍCIA  
COM FLUXOGRAMA**

2ª EDIÇÃO

GOIÂNIA  
CONTATO COMUNICAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA – FM / UFG

2014

Copyright © 2014 by Waldemar Naves do Amaral, Washington Luiz  
Ferreira Rios e demais autores  
Projeto Gráfico: Contato Comunicação

CIP — Brasil — Catalogação na Fonte  
BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL PIO VARGAS

|             |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RIOS<br>man | Rios, Washington Luiz Ferreira.<br>Manual Prático de Obstetrícia. / Waldemar Naves do<br>Amaral, Washington Luiz Ferreira Rios - Goiânia: Contato<br>Comunicação Ltda<br>422 p.<br><br>1. Medicina - Manual prático. I.Título. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CDU: 618.2

**DIREITOS RESERVADOS** - É proibida a reprodução total ou parcial da obra, de qualquer forma ou por qualquer meio sem a autorização prévia e por escrito do autor. A violação dos Direitos Autorais (Lei n.º 9610/98) é crime estabelecido pelo artigo 48 do Código Penal.

**Universidade Federal de Goiás**

Orlando Afonso Valle do Amaral

*Reitor*

Faculdade de Medicina

Vardeli Alves de Moraes

*Diretor*

Departamento de Ginecologia e Obstetrícia

Waldemar Naves do Amaral

*Chefe*

**Conselho Editorial do Departamento de  
Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de  
Medicina da Universidade Federal de Goiás**

Dejan Rodrigues Nonato

José Miguel de Deus

Juarez Antônio de Sousa

Mário Approbatto

Maurício Guilherme Campos Vigianno

Rodopiano de Souza Florêncio

Rosane Figueiredo Alves

Ruffo de Freitas Júnior

Rui Gilberto Ferreira

Waldemar Naves do Amaral

Washington Luiz Ferreira Rios



# SUMÁRIO

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| MÓDULO I – GESTAÇÃO PADRÃO                              | 21      |
| DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ                                 | 23      |
| PARTOGRAMA                                              | 27      |
| CONTRATILIDADE UTERINA                                  | 37      |
| INDUÇÃO DO PARTO                                        | 43      |
| ANALGESIA NO TRABALHO DE PARTO                          | 50      |
| EXAME FÍSICO DA GESTANTE                                | 55      |
| SEXUALIDADE NA GRAVIDEZ                                 | 59      |
| <br>MÓDULO II – MEDICINA FETAL                          | <br>67  |
| MEDICINA FETAL                                          | 69      |
| ESTUDO GENÉTICO PRÉ-NATAL                               | 76      |
| PROCEDIMENTOS INVASIVOS EM OBSTETRÍCIA                  | 82      |
| ACONSELHAMENTO GENÉTICO PRÉ-NATAL                       | 88      |
| TERAPIA FETAL                                           | 92      |
| <br>MÓDULO III – PROPEDEÚTICA EM OBSTETRÍCIA            | <br>99  |
| EXAMES DE ROTINA DE PRÉ-NATAL                           | 101     |
| ULTRASSONOGRAFIA EM OBSTETRÍCIA                         | 108     |
| AValiação DA VITALIDADE FETAL                           | 111     |
| AValiação DA Maturidade FETAL                           | 118     |
| <br>MÓDULO IV – PATOLOGIA E INTERCORRÊNCIAS NA GRAVIDEZ | <br>123 |
| HIPERÊMESE GRAVÍDICA                                    | 125     |
| ABORTO                                                  | 128     |
| DOENÇA TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL                        | 135     |
| GRAVIDEZ ECTÓPICA                                       | 149     |
| HEMORRAGIA NA SEGUNDA METADE DA GESTAÇÃO                | 153     |
| GEMELIDADE                                              | 164     |
| GESTAÇÃO PROLONGADA                                     | 175     |
| OLIGOÂMNIO E POLIHIDRÂMNIO                              | 181     |
| INCOMPETÊNCIA ISTMOCERVICAL                             | 185     |
| TRABALHO DE PARTO PREMATURO                             | 190     |
| DOENÇA HEMOLÍTICA PERINATAL                             | 197     |
| DOENÇA HIPERTENSIVA ESPECÍFICA DA GESTAÇÃO (DHEG)       | 204     |
| HIPERTENSÃO ARTERIAL CRÔNICA (HAC)                      | 213     |
| RETARDO DO CRESCIMENTO INTRAUTERINO                     | 219     |
| INFECÇÕES CONGÊNITAS                                    | 225     |
| AMNIOCORREXIA PREMATURA                                 | 232     |

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| INFECÇÃO URINÁRIA NA GESTAÇÃO                       | 240     |
| SEPSIS                                              | 245     |
| DIABETES E GESTAÇÃO                                 | 255     |
| DOENÇAS TIREOIDIANAS NA GESTAÇÃO                    | 263     |
| TROMBOFILIAS NA GESTAÇÃO                            | 271     |
| GESTAÇÃO E TROMBOEMBOLISMO                          | 276     |
| DOENÇAS HEPÁTICAS E GRAVIDEZ                        | 282     |
| SOFRIMENTO FETAL AGUDO                              | 287     |
| ÓBITO FETAL                                         | 291     |
| CÂNCER GINECOLÓGICO E GRAVIDEZ                      | 296     |
| <br>MÓDULO V: TOCOCIRURGIA                          | <br>301 |
| FÓRCEPS                                             | 303     |
| VERSÃO E ASSISTÊNCIA AO PARTO PÉLVICO               | 308     |
| <br>MÓDULO VI: PUERPÉRIO E LACTAÇÃO                 | <br>317 |
| PUERPÉRIO FISIOLÓGICO                               | 319     |
| HEMORRAGIA PÓS-PARTO                                | 322     |
| INFECÇÃO PUERPERAL                                  | 325     |
| DEPRESSÃO PÓS-PARTO - PSICOSE PUERPERAL             | 335     |
| ANTICONCEPÇÃO NO PUERPÉRIO                          | 339     |
| ALEITAMENTO MATERNO                                 | 342     |
| INIBIÇÃO DA LACTAÇÃO                                | 355     |
| <br>MÓDULO VII: EPIDEMIOLOGIA EM OBSTETRÍCIA        | <br>361 |
| MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL                       | 363     |
| ESTATÍSTICA FETAL                                   | 370     |
| MORTALIDADE PERINATAL                               | 377     |
| <br>MÓDULO VIII: ÉTICA E LEI EM OBSTETRÍCIA         | <br>387 |
| ASPECTOS ÉTICOS NA GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA        | 389     |
| RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL MÉDICA EM OBSTETRÍCIA | 395     |
| ATENDIMENTO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL            | 403     |
| INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ                             | 412     |

# PREFÁCIO

***Professor Maurício Guilherme de Campos Viggiano***

O Manual Prático de Obstetrícia do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, foi organizado pelos Profs. Washington Luiz Ferreira Rios e Waldemar Naves do Amaral revelando a orientação eminentemente didática desse livro e que tem sido o motivo do sucesso do mesmo e da sua aceitação universal.

Embora revelando uma escola tradicional é contudo um trabalho precioso, particularmente para o estudante, ou melhor, para os que iniciam nos estudos obstétricos, que podem nele ver o verdadeiro “abc” da obstetrícia.

A divisão didática da matéria, as ilustrações magníficas que ornaram suas páginas, o interesse que os estudos da patologia e intercorrências na gravidez, para só fazer algumas referências, merecem dos organizadores, demonstram plenamente o valor da obra que agora é apresentada aos leitores.

Foi por isso que acendi de bom grado ao convite para prefaciar esse excelente Manual.

Goiânia, abril de 2014

***Prof. Maurício Guilherme de Campos Viggiano,***  
***Diretor geral do Hospital e Maternidade Dona Íris***





# MENSAGEM DO AUTOR

WALDEMAR NAVES DO AMARAL

Um departamento científico de uma universidade tem o dever precípua de promover o ensino na graduação, pesquisa em todos os setores e em especial na pós-graduação sensu stricto, extensão nos procedimentos extra-muro da unidade, além de prestação de serviços à conformidade a que assiste.

Este compêndio, já na sua 2ª apresentação contempla todos aqueles itens com o desejo de caminhar na direção e no sentido da plenitude do conhecimento.

Assim, com a colaboração de excelência dos docentes, dos médicos e dos discentes deste departamento, queremos que este livro possa nortear os rumos da ginecologia obstétrica do Estado de Goiás.

***Prof. Dr. Waldemar Naves do Amaral,***

***Professor adjunto e chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da  
Universidade Federal de Goiás e diretor acadêmico do Hospital e Maternidade Dona Íris***



# MENSAGEM DO AUTOR

WASHINGTON LUIZ FERREIRA RIOS

Novamente, no sentido de proporcionar uma leitura dinâmica e agradável da obstetrícia, revisamos nosso manual. A obstetrícia é uma ciência dinâmica e sofre alterações quase diárias e portanto, por si só, já justifica a revisão deste manual.

Mais atualizado e completo serve a nossos estudantes e colegas para relembrar e atualizar os temas mais importantes em obstetrícia. Contamos e desde já agradecemos aos colegas e professores que novamente nos ajudaram nesta árdua função.

Pretendemos que com este manual possam fazer bom uso e aplicar uma obstetrícia de boa qualidade a suas pacientes. Mais uma vez tentamos difundir as condutas praticadas no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás.

Agradecemos aos amigos, patrocinadores e a chefia do departamento pela atitude de sempre estar buscando o melhor da ciência a todos e levando os conhecimentos para fora dos muros da universidade. Que possam fazer bom uso deste material e que ele lhe possa ser útil em sua vida obstétrica.

***Prof. Ms. Washington Luiz Ferreira Rios,***  
***Professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da***  
***Universidade Federal de Goiás***



## AUTORES

**Alexandre Vieira Santos Moraes** - Professor doutor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da FM/UFG.

**Ana Flávia Ribeiro dos Santos** - Médica especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela FM/UFG.

**Ana Carolina Lamarque** - Acadêmica de Musicoterapia da UFG.

**Auseni Bento Ferreira Viggiano** - Enfermeira obstétrica.

**Carolina Oliveira de Jesus** - Acadêmica de Medicina da FM/UFG.

**Carolina Rodrigues de Mendonça** - Fisioterapeuta Especializada em Fisioterapia na Saúde da Mulher pelo Centro de Estudos Avançados e Fisioterapia Integrada, Goiânia (GO).

**Clayton de Souza Fortunato Filho** - Médico especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela FM/UFG.

**Dejan Rodrigues Nonato** - Professor auxiliar mestre do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da FM/UFG.

**Fernando de Oliveira Resende Filho** - Médico residente do Hospital Regional Dr. Homero de Miranda Gomes, São José/SC.

**Fernando Protásio Carneiro** - Médico anestesista do CEA/Goiânia.

**Flávia Tandaya Grandi** - Acadêmica de Medicina da FM/UFG.

**Gabrielle Miguel Cruvinel Câmara** - Médica especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela FM/UFG.

**Giovanni Ferreira Viggiano** - Acadêmico de Medicina da FM/UFG.

**Gustavo Coelho Caiado** - Acadêmico de Medicina da FM/UFG.

**Iulla Aguiar da Silveira** - Médica especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela FM/UFG.

**Jacqueline de Aquino Castro** - Doutora em Medicina pela UNIFESP e médica do Hospital das Clínicas FM/UFG.

**Jaqueline Nogueira de Souza** - Acadêmica de Medicina da FM/UFG.

**Larissa Siqueira Leal** - Acadêmica de Medicina da FM/UFG.

**Lorena Apolinário Martins** - Médica especialista em Ginecologia e Obstetrícia.

**Luana de Rezende Mikael** - Acadêmica de Medicina da FM/UFG.

**Luiz Augusto Antonio Batista** - Professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da FM/UFG.

**Luiz Augusto Teixeira Batista** - Acadêmico de Medicina da PUC-Goiás

**Marcelo Braga Viggiano** - Professor doutor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da FM/UFG.

**Marcos Augusto Filisbino** - Professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da FM/UFG.

**Marcos Lázaro de Souza Gondim** - Médico especialista em Ginecologia e Obstetrícia do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da FM/UFG.

**Marcus Vinicius Batista Machado** - Acadêmico de Medicina da PUC-GO

**Mariana Costa Borges** - Acadêmica de Medicina da Universidade Federal de Goiás.

**Mariana Marins Filisbino** - Acadêmica de Medicina da Universidade Federal do Tocantins.

**Mário Approbato** - Professor adjunto doutor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da FM/UFG.

**Mariza Martins Avelino** - Professora Associada do Departamento de Pediatria e Puericultura da Faculdade de Medicina da UFG.

**Marun A. D. Kabalan** - Advogado, assessor jurídico da Associação Médica de Goiás, Sindicato dos Médicos no Estado de Goiás e de Associações de Especialidades Médicas.

**Mauricio Guilherme Campos Viggiano** - Professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da FM/UFG, Chefe do Ambulatório de Mola do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da FM/UFGO.

**Natália Mirelle Carrijo dos Santos** - Acadêmica de Medicina da Universidade Federal de Goiás.

**Nayanne de Lima Malta** - Acadêmica de Medicina da Universidade Federal de Goiás.

**Noara Barros Ribeiro** - Acadêmica de Medicina da Universidade Federal de Goiás.

**Pâmella Deuzila de Oliveira Schelle** - Acadêmica de Medicina da FM/UFG.

**Paola Patricia Castillo Velásquez** - Acadêmica de Medicina da Universidade Federal de Goiás.

**Raul Carlos Barbosa** - Médico especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela FM/UFG.

**Reinaldo Satoru Azevedo Sasaki** - Médico especialista em Ginecologia e Obstetrícia do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da FM/UFG.

**Renato Sampaio Tavares** - Professor da Universidade Federal de Goiás.

**Rickella Aparecida Alves Moreira** - Acadêmica de Medicina da FM/UFG.

**Rita de Cássia Borges** - Ginecologista-Obstetra, coordenadora do ambulatório de Pré-Natal de Baixo Risco do HC-UFG.

**Rodrigo Brum Von Kriiger** - Médico.

**Ronaldo Figueiredo Alves** - Médico Residente do 2º ano de Cirurgia Geral do HC/FM/UFG.

**Rosane Ribeiro Figueiredo Alves** - Professora adjunta doutora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da FM/UFG.

**Rui Gilberto Ferreira** - Professor adjunto doutor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da FM/UFG.

**Samuel Marins Filisbino** - Médico pela PUC-Goiás.

**Sarah Hasimyan Ferreira** - Acadêmica de Medicina da Universidade Católica de Brasília.

**Thuanly Calvalcante Silva** - Acadêmica de Enfermagem da UFG.

**Vardeli Alves de Moraes** - Professor associado do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da FM/UFG.

**Waldemar Naves do Amaral** - Professor adjunto doutor e chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da FM/UFG.

**Waldemar Naves do Amaral Filho** - Acadêmico de Medicina da Universidade Católica de Brasília.

**Walter Costa Borges** - Médico Residente do 1º ano de Ginecologia e Obstetrícia do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFG.

**Washington Luiz Ferreira Rios** - Professor assistente mestre do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da FM/UFG.

**Yara Alves Caetano** - Acadêmica de Medicina da FM/UFG.

**Wirley Alves de Mendonça Júnior** - Acadêmica de Medicina da FM/UFG

**Zelma Bernardes Costa** - Professora Assistente do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFG e Mestre em Epidemiologia pelo IPTSP/UFG.

**Zulminere Cardoso Fonseca** - Especialista e mestre em Ginecologia e Obstetrícia.





# MÓDULO I – GESTAÇÃO PADRÃO



# DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ

DEJAN RODRIGUES NONATO\*

NAYANNE DE LIMA MALTA\*\*

\*Professor auxiliar mestre do Departamento de Ginecologia e  
Obstetrícia da FM/UFG

\*\*Acadêmica de Medicina da Universidade Federal de Goiás

## INTRODUÇÃO

O diagnóstico de gravidez vem se tornando cada vez mais seguro e precoce. Na última década, o desenvolvimento de técnicas imunológicas e o emprego da ultrassonografia transvaginal possibilitaram o diagnóstico correto de gestação na falha menstrual.

Didaticamente, o diagnóstico de gravidez pode ser dividido em clínico, laboratorial e ultrassonográfico.

## DIAGNÓSTICO CLÍNICO

São utilizados dados propedêuticos relacionados à anamnese, inspeção, palpação, toque, ausculta e pela medida da temperatura basal.

O atraso menstrual em mulher eumenorreica, com vida sexual ativa, é o primeiro e mais importante sintoma clínico para presunção diagnóstica de prenhez. Entretanto, a amenorreia pode estar presente em pacientes não-grávidas com condições como aleitamento, endocrinopatias, anemia grave, cistos de ovário, pílulas anticoncepcionais, dentre outras. Além disso, deve-se considerar a possibilidade, apesar de rara, de ocorrerem perdas sanguíneas regulares até o 3º- 4º mês de gestação.

Náuseas e vômitos, aparentemente sem causa, são frequentes até a 10ª semana de gestação. A queixa de polaciúria (por compressão da bexiga pelo corpo uterino) é também comum, bem como a queixa de mastalgia bilateral. Podem estar presentes ainda cólicas leves no hipogástrio, principalmente em primigestas, e sialorreia persistente.

A referência de movimentação fetal são relativamente tardias; nas múltiparas ocorre em torno da 16ª -18ª semanas, e nas primigestas entre a 18ª-20ª semanas.

À inspeção, observa-se, após a 8ª semana, coloração arroxeada do vestíbulo e da parede vaginal anterior (sinal de Jacquemier-Kluge), decorrente da congestão venosa local. Pode ser visível ainda o cloasma gravídico, rede de Haller e tubérculos de Montgomery nas mamas, além de pigmentação da linha alva, estrias recentes e aumento de volume abdominal, aparecimento ou crescimento de varizes em membros inferiores.

À palpação, a partir da 10<sup>o</sup>-12<sup>o</sup> semanas, o corpo uterino pode ser palpado na área hipogástrica. Após a 10<sup>o</sup> semana ou antes, a expressão das mamas pode identificar o escoamento do colostro.

Ao toque vaginal, observa-se que tanto corpo quanto colo uterino sofrem processo de amolecimento, com isso, a consistência com impressão de cartilagem de nariz passa a ser de lábio. O amolecimento do istmo (sinal de Hegar) é pressentido pelo toque combinado a partir da 6<sup>o</sup>-8<sup>o</sup> semanas. O corpo uterino torna-se pastoso e mais facilmente apreendido pelo toque combinado (sinal de Holzapfel) e, em virtude do amolecimento ístmico, acentua sua anteversoflexão (sinal de MacDonald). Por volta da 6<sup>o</sup>-7<sup>o</sup> semanas, quando a nidação ovular é cornual, observa-se maior desenvolvimento do hemiútero correspondente e assimetria uterina (sinal de Piskacheck). Em seu crescimento, o corpo uterino de piriforme passa a globoso, preenchendo os fundos de saco laterais (sinal de Nobile-Budin). Observa-se ainda sensação de rechaço quando se pressiona bruscamente para cima o fundo de saco anterior (sinal de Puzos).

O sonar-Doppler pode identificar os batimentos cardíacos fetais a partir de 10 semanas. Já com o estetoscópio clínico de Pinard, o fato somente será possível em torno da 18<sup>o</sup>-20<sup>o</sup> semanas.

O exame da curva térmica, a partir do último dia da menstruação, e a comprovação de sua elevação sustentada e permanente por mais de 16 dias, sugerem a ocorrência da fecundação.

## **DIAGNÓSTICO LABORATORIAL**

O diagnóstico laboratorial de gravidez baseia-se no encontro do hormônio gonadotrófico coriônico (hCG) na urina ou no sangue materno.

O primeiro teste acurado para o diagnóstico de gravidez foi desenvolvido por Aschheim e Zondek, em 1928, após demonstrarem a presença de uma substância gonadoestimulante no sangue e urina de mulheres grávidas, utilizando ratas. Esse tipo de teste, chamado biológico, atualmente foram superados por teste imunológicos, devido a maior sensibilidade, simplicidade e rapidez das técnicas desenvolvidas a partir de 1960.

O hCG é um hormônio glicoproteico produzido na placenta, provavelmente pelo sincitiotrofoblasto, a partir do 10<sup>o</sup> dia da fertilização, ou seja, quatro dias antes da falha menstrual. Aumenta, progressivamente, até a 12<sup>o</sup> semana, caindo posteriormente. Possui duas cadeias peptídicas: alfa e beta.

Os métodos imunológicos utilizados na urina são a prova de inibição da hemaglutinação e a prova de hemaglutinação invertida. A primeira é comercialmente conhecida como Pregnosticon All-in e possui sensibilidade de 1.000 UI/litro; já a segunda, é designada Neo-Pregnosticon e tem sensibilidade de 150 UI/litro. Podem apresentar reação cruzada com o LH hipofisário, resultando em

reações falso-positivas em caso de aumento do LH hipofisário (menopausa), drogas (fenotiazidas, anticonvulsivantes, hipnóticos), anticoncepcionais orais, proteinúria. As reações falso-negativas decorrem de níveis insuficientes de hCG ou de condições de insuficiência da passagem do hCG ao organismo materno, dependente do ovo (abortamento) ou do local de nidificação (preghez ectópica).

Quando se utilizam provas com urina, a recomendação é que a amostra seja da primeira micção matinal, na qual há maior concentração do hormônio.

Com o objetivo de obter maior sensibilidade e especificidade com as reações imunológicas, substitui-se a urina pelo sangue, dosando-se a subunidade beta do hCG. O teste é realizado por técnicas como RIA (radioimuno ensaio) e ELISA. A gestação pode ser confirmada de 8 a 11 dias após a fecundação, ou seja, cerca de quatro dias antes da falha menstrual. Esta é, atualmente, a prova mais sensível e precoce para o diagnóstico de preñez. A maioria dos testes tem sensibilidade para detecção de gravidez entre 25 a 30 mUI/ml. Resultados falso-positivos ocorrem na faixa entre 2 a 25 mUI/ml. Do ponto de vista prático, níveis menores que 5 mUI/ml são considerados negativos e acima de 25 mUI/ml são considerados positivos.

## DIAGNÓSTICO ULTRASSONOGRÁFICO

O ultrassom obstétrico é o método de investigação complementar mais utilizado em obstetrícia, não invasivo e sem efeitos colaterais ou teratogênicos descritos até o momento. O notável desenvolvimento dos aparelhos possibilitou, com grande precisão, o diagnóstico de gravidez nas duas primeiras semanas da falha menstrual.

A ultrassonografia com transdutor abdominal permite a visualização do saco gestacional na 6ª semana, a partir do início da última menstruação, ou no 42º dia do ciclo menstrual.

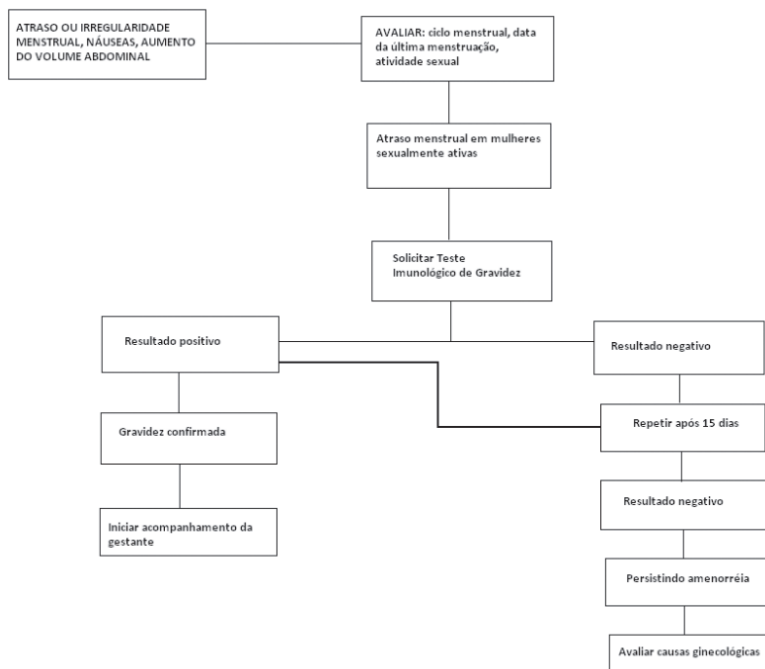
A ultrassonografia transvaginal levou a maior precocidade no diagnóstico, já que tem sido descrita a presença de saco gestacional visível com apenas 2mm de diâmetro, referente ao 2º dia de falha.

Além disso, a ultrassonografia é importante para confirmar se a gestação é tópic-a ou ectópica, para estimar a idade gestacional ou diagnosticar gestação múltipla.

A estrutura mais precocemente identificada é o saco gestacional. Este pode ser visto nas imagens ultrassom transvaginal por volta da 4ª-5ª semanas de gestação e cresce a uma taxa de 1 mm / dia em gestação recente. Por volta de 5,5-6 semanas de gestação, um sinal de dupla decidual pode ser visto, que é o saco gestacional cercado pela decídua espessada. A presença de saco gestacional no início pode ser confundida com uma pequena coleção de líquido ou sangue ou o pseudo saco gestacional de uma gravidez ectópica. Devido a isso, o diagnóstico de gravidez intrauterina não deve ser feito com base apenas na visualização do mesmo.

O saco vitelínico pode ser reconhecido na 4<sup>a</sup>-5<sup>a</sup> semana de gestação e é visto até aproximadamente 10 semanas. É uma pequena esfera com um centro hipoeoico e está localizado dentro do saco gestacional.

Da mesma forma, um saco vitelínico maior do que sete milímetros, sem evidências de um polo de desenvolvimento fetal sugere uma gravidez inviável. O diagnóstico de gravidez intrauterina pode ser feita assim que o saco vitelino está presente, o que também exclui a gravidez ectópica, exceto no caso raro de gravidez heterotópica.



*Adaptado de Ministério da Saúde. Assistência Pré-Natal Manual Técnico. Brasília, 2000*

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. BAUER, A; NEME, B. Diagnóstico Obstétrico. In: NEME, B. Obstetrícia Básica. São Paulo: Sarvier; 2000. p.112-117.
2. LINHARES, E. Propedêutica de gravidez: Diagnóstico laboratorial. In: REZENDE J. Obstetrícia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2002. p. 178-179.
3. SAVAGE Jr P.M, VALERIO G. Ovarian Hyperemia Pregnancy Test. California Medicine, San Bernardino. v.98, n.3, p.137-138, 1963.
4. Shields AD. Pregnancy diagnosis. Disponível em: <http://emedicine.medscape.com/article/262591-overview#aw2aab6b4>. Acesso em: 12 ago. 2011.
5. AIUM Practice Guideline for the Performance of Obstetric Ultrasound Examinations. Disponível em: <http://www.aium.org/publications/guidelines/obstetric.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2011.
6. Melo VH, Pires do Rio SM. Projeto diretrizes: Assistência Pré-Natal. Disponível em: [www.projetoDiretrizes.org.br/projeto\\_diretrizes/081.pdf](http://www.projetoDiretrizes.org.br/projeto_diretrizes/081.pdf). Acesso em: 12 ago. 2011.
7. Ministério da Saúde. Assistência Pré-Natal Manual Técnico. Brasília. Disponível em: [bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd04\\_11.pdf](http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd04_11.pdf). Acesso em: 12 ago.2011.